

○ 原因は口腔内の嫌気性菌や連鎖球菌が多く、その他に黄色ブドウ球菌や肺炎桿菌、肺炎球菌、緑膿菌なども原因となる。

○ 特に結核との鑑別を十分に行う。

1

× 嫌気性菌が関与していることが多いが、喀痰培養では検出されにくいいため、嫌気性菌をスペクトラムに含めた抗菌薬選択（例：アンピシリン/スルバクタム）を行う。

× 膿胸ではドレナージが望ましい場合が多いが、肺化膿症では抗菌薬治療に反応することが多い。外科的切除は内科的治療に反応しない場合の選択肢として考慮する。

○ 抗酸菌、真菌、ノカルジア、寄生虫による感染症や悪性腫瘍・血管炎などの非感染性疾患も鑑別となるため、CTや気管支鏡検査による十分な評価が望ましい。

○

× 夜間を中心に、気づかないうちに鼻腔咽頭などからの分泌物を誤嚥する不顕性誤嚥が原因となることが多い。

× 直接誤嚥を確認することは稀であり、嚥下機能障害の存在と画像上の肺炎所見および末梢血白血球数の上昇によって診断する。

○ 検査による誤嚥のリスクを考慮し、病状を把握しながら必要に応じて嚥下造影などの詳細検査を追加する。